DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: JHON JABER SALINAS SERNA **Identificación** CC 1116282786
Edad: 27 AÑOS **Empresa:** EMSSANAR S.A.S SUBSIDIADO-2025-2
Sala: QUIROFANO 2 **Fecha programación de cirugía:** 04/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
2	030301	EXPLORACION Y DESCOMPRESION DE RAIZ DEL NERVIO ESPINAL	EGP	
Cirujano:	JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO	**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
1	030405	DRENAJE DE COLECCION EPIDURAL TORACICA	EGR	
Cirujano:	JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO	**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
1	030406	DRENAJE DE COLECCION EPIDURAL LUMBOSACRA	EGS	
Cirujano:	JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO	**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
1	036101	LISIS O RESECCION DE ADHERENCIAS EXTRADURALES EN MEDULA ESPINAL O RAICES DE NERVIOS ESPINALES VIA ABIERTA	EKM	
Cirujano:	JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO	**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
2	038201	NEUROLISIS DE RAICES ESPINALES	BQF	
Cirujano:	JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO	**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
2	385402	CIERRE, PINZAMIENTO O LIGADURA DE VASOS ESPINALES	DTO	
Cirujano:	JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO	**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
2	770931	DRENAJE, CURETAJE, SECUESTRECTOMIA DE COLUMNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR O POSTEROLATERAL	BTL	
Cirujano:	JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO	**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
2	778964	VERTEBRECTOMIA PARCIAL TORACICA VIA POSTERIOR	EOY	
Cirujano:	JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO	**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
1	862601	DESBRIDAMIENTO CON COLOCACION DE DISPOSITIVO DE PRESION SUBATMOSFERICA	A35	
Cirujano:	JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO	**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES219 JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO **Especialidad** NEUROCIRUGIA

030301 EXPLORACION Y DESCOMPRESION DE RAIZ DEL NERVIO ESPINAL
030405 DRENAJE DE COLECCION EPIDURAL TORACICA
030406 DRENAJE DE COLECCION EPIDURAL LUMBOSACRA
036101 LISIS O RESECCION DE ADHERENCIAS EXTRADURALES EN MEDULA ESPINAL O RAICES DE NERVIOS ESPINALES VIA ABIERTA
038201 NEUROLISIS DE RAICES ESPINALES
385402 CIERRE, PINZAMIENTO O LIGADURA DE VASOS ESPINALES
770931 DRENAJE, CURETAJE, SECUESTRECTOMIA DE COLUMNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR O POSTEROLATERAL
778964 VERTEBRECTOMIA PARCIAL TORACICA VIA POSTERIOR
862601 DESBRIDAMIENTO CON COLOCACION DE DISPOSITIVO DE PRESION SUBATMOSFERICA

Dx Preoperatorio: S220 FRACTURA DE VERTEBRA TORACICA

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

Dx Postoperatorio: S220 FRACTURA DE VERTEBRA TORACICA

G062 ABSCESO EXTRADURAL Y SUBDURAL NO ESPECIFICADO

Tipo de Herida: LIMPIA CONTAMINADA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 400 **ml.** **Vía:** DIFERENTE VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 04/11/26 **Fecha Final** 04/11/26
Hora Inicio 10:47:00 **Hora Final** 12:23:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
PREVIO DILIGENCIAMIENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y LISTA DE CHEQUEO.
PROFILAXIS ANTIBIOTICA CON CLINDAMICINA - AZTREONAM - CAFAZOLINA.
PACIENTE BAJO ANESTESIA GENERAL .
DECÚBITO PRONO, REALCE DEL TORSO, PROTECCION AREAS DE PRESION, OJOS Y GENITALES.
SE REALIZA ASEPSIA Y ANTISEPSIA CON CLORHEXIDINA.
COLOCACION DE CAMPOS OPERATORIOS ESTERILES
VÍA 1 TORACICA:
SE OBSERVA DEHISCENCIA DE HERIDA A POLO CAUDAL, SE REALIZA DESBRIDAMIENTO DE HERIDA PREVIA RETIRANDO PUNTOS DEHISCENTES.
REALIZO RESECCION DE FISTULA ESPINO CUTANEA Y ENVIO MUESTRA A CULTIVO.
SE REALIZA ABORDAJE AMPLIADO EXPONIENDO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS.
SE EVACUAN COLECCIONES PURULENTAS PARAESPINALES - EPIDURALES.
REALIZO SECUESTRECTOMIA EN COLUMNA.
SE OBSERVAN ABUNDANTES MEMBRANAS DE FIBRINA Y TEJIDO NECROTICO, SE REALIZA DISECCIÓN SUBPERIÓSTICA , SE EXPONEN LAS FACETAS ARTICULARES , Y LOS PROCESOS TRANSVERSOS , SE OBSERVA MATERIAL DE INSTRUMENTACION CON TORNILLOS TRANSPEDICULARES Y BARRAS LATERALES.
DESBRIDAMIENTO DE TEJIDO MUSCULAR HASTA OBTENER TEJIDO VITAL SANGRANTE, HEMOSTASIA CON BIPOLAR PARA OCLUSION DE VASOS EPSINALES SANGRANTES.
VERTEBRECTOMIA PARCIAL Y SE ENVIA MATERIAL A CULTIVOS CON COLECCION EPIDURAL Y TEJIDO PARAVERTEBRAL.
SE APRECIA VASO ESPINAL LUMBAR SANGRANTE , SE REALIZA OCLUSIÓN DE VASO ESPINAL SANGRANTE .
LAVADO CON Y DESBRIDAMIENTO - CURETAJE OSEO Y MUSCULAR CON SOLUCION DE POVIDONA SOLUCION MAS ESPUMA Y PEROXIDO DE HIDROGENO REALIZANDO CURETAJE TISULAR EN CUATRO OPORTUNIDADES.
QUE SE LAVA LA LODGE QUIRURGICA CON 3000CC DE SSN
SE APRECIA COMPRESIÓN DE LAS RAÍCES ESPINALES LUMBARES POR TEJIDO INFLAMATORIO PURULENTO FIBROSO.
SE REALIZA DESCOMPRESIÓN DE RAÍCES ESPINALES LUMBARES , SE APRECIAN ADHERENCIAS EXTRADURALES INFLAMATORIA, SE RELIAZA LISIS DE ADHERENCIAS EXTRADURALES INFLAMATORIAS.
BAJO VISION DIRECTA SE IDENTIFICAN RAICES ESPINALES DORSALES Y SE REALIZA NEUROLISIS CON SUSTANCIA QUIMICA DE RAICES ESPINALES T7 A T12 BILATERALMENTE PARA MANEJO DE DOLOR POSQUIRURGICO.
VIA 2 LUMBAR:
HERIDA PREVIA CON DEHISCENCIA Y SECRECION FIBRINOIDE PURULENTA.
RETIRO PUNTOS DEHISCENTES DISECICON POR PLANOS, TEJIDO EPDIRUAL FIBRINOIDE PURULENTO .
SE REALIZA DREANJE DE COLECCION EPIDURAL. ZONAS DE NECROSIS Y FIBROSIS , SE REALIZA DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO DESVITALIZADO HASTA OBTENER TEJIDO SANO. SE REALIZA
SECUESTRECTOMIA LUMBAR. VERTEBRECTOMIA PARCIAL LUMBAR Y ENVIO MUESTRAS DE COLECCION VERTEBRAL, HUESO, COLECCION PERIDURAL Y TEJIDO PARAVERTEBRAL.
SE APRECIAN AHERENCIAS EXTRADURALES INFLAMATORIAS , SE RELAIZA LISIS DE ADHERENCIAS EXTRADURLAES CON DISECCDOIN ROMA E HIDRO DISECCION. SE APRECIA VASO ESPINAL LUMBAR SANGRANTE , SE REALIZA OCLUSIÓN DE VASOESPINAL SANGRANTE CON PINZA BIPOLAR.
REALIZO LAVADO EN DOS OPORTUNIDADES CON IGUAL MEZCLA QUE EN REGION TORACICA Y LAVO CON 2000CC DE SSN,
BAJO VISION DIRECTA SE IDENTIFICAN RAICES ESPINALES LUMBARES Y SE REALIZA NEUROLISIS CON SUSTANCIA QUIMICA PARA MANEJO DE DOLOR POSQUIRURGICO A LAS REICES ESPINALES L1L2L3 DERECHAS E IZQUIERDAS.
SE REALIZA AFRONTAMIENTO MIOFASCIAL DE LAS HERIDAS CON PUNTOS DE VYCRIL 1.
CIERRE DE TCSC CON MULTIPLES PUNTO SEPARADOS DE VYCRIL 1 Y 2-0 INTERCALADOS
CIERRE CUTANEO CON MULTIPLES PUNTOS COLCHONERO DE PROLENE 1.
SE IMPLANTA SISTEMA DE PRESION SUBATMOSFERICA DE MODO HERMETICO.
SE DEJA FUNCIONANDO CON PRESION DE 100MMHG.
NO COMPLICACIONES SE TRASLADA A SALA DE RECUPERACION ANESTESICA

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :

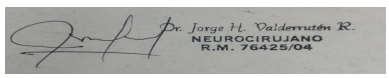
DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

FISTULA ESPINO CUTANEA.
VASOS ESPINALES ROTOS.
ESTENOSIS DEL CANAL ESPINAL TORACICO
TEJIDO FIBRINOIDE PURULENTO PEIDURAL Y VERTEBRAL
TEJIDO NFLAMATORIO FIBROSO EPIDURAL TORACICO Y LUMBAR CON COMPRESION MEDULAR SEGMENTARIA.
ADHERENCIAS ESPINALES Y NERVIOS COMPROMIDOS EN REGION TORACICA Y LUMBAR.
PULL OUT DE LOS TORNILLOS INFERIORES DEL CONSTRUCTO QUE INESTABILIZAN PARCIALMENTE EL SISTEMA, SE EVIDENCIA CIFOTIZACION DE LAS DOS VERTEBRAS FRACTURADAS.

Tejidos enviados a patología : **SI** ☐ **NO** ☒

OTROS PARTICIPANTES

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO
AX619	HAROLD FERNANDO CHACON FLOR	ANESTESIOLOGO
ES219	JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO	ESPECIALISTA
MG29	JAIME LOPEZ	AYUDANTE



JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO
Reg. 76425
NEUROCIRUGIA

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***